

AUTORA: Yahara Isabel Olvera Ibarra

Hospital General de Torreón (H.G.T.)
Universidad Autónoma de Coahuila

INTRODUCCIÓN

La hernia diafragmática congénita tipo Bochdalek es un defecto posterolateral del diafragma que permite el paso de vísceras abdominales hacia la cavidad torácica. Se presenta con mayor frecuencia del lado izquierdo y puede manifestarse en el periodo neonatal con dificultad respiratoria de severidad variable. Su importancia radica en la compresión pulmonar, alteración de la mecánica ventilatoria y necesidad de corrección quirúrgica oportuna.

FISIOPATOLOGÍA

Durante el desarrollo embrionario ocurre una falla en el cierre del canal pleuroperitoneal, generando un defecto diafragmático posterolateral. A través de este defecto, asas intestinales, estómago u otras vísceras abdominales pueden ascender al tórax, ocupando espacio pulmonar. Esto condiciona compresión del pulmón ipsilateral, desplazamiento mediastinal y, en casos severos, hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar neonatal.

RESULTADOS

Presentación del caso

Recién nacido masculino de 3 días de vida, con peso aproximado de 3,240 g, ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con diagnóstico de hernia diafragmática congénita izquierda tipo Bochdalek.

A la valoración inicial presentó frecuencia cardíaca de 128 lpm, frecuencia respiratoria de 52 rpm, temperatura de 36.2 °C y saturación de oxígeno de 85%, se coloca CPAP con saturación final a 98%. Se indicó ayuno, soluciones intravenosas, monitorización continua y vigilancia estrecha como parte de la estabilización neonatal previa al tratamiento definitivo.

Hallazgos de laboratorio

En los estudios paraclínicos destacaron los siguientes resultados:

Estudio	Resultado		
Leucocitos	8.58 ×10 ³ /μL	Creatinina sérica	0.50 mg/dL
Hemoglobina	18.79 g/dL	Sodio	134 mEq/L
Hematocrito	53.50%	Potasio	3.5 mEq/L
Plaquetas	127.10 ×10 ³ /μL	Cloro	103 mEq/L
TP	13.9 s	Calcio sérico	8.6 mg/dL
INR	1.22	Bilirrubina total	10.8 mg/dL
TPT	37.2 s	Bilirrubina ind.	10.4 mg/dL
Glucosa	100 mg/dL	AST/TGO	40 U/L
		Proteína C reactiva	29.1 mg/dL

Hallazgos radiológicos

La radiografía toracoabdominal preoperatoria mostró hallazgos compatibles con hernia diafragmática congénita izquierda tipo Bochdalek, con presencia de contenido abdominal en hemitórax izquierdo, disminución de la expansión pulmonar ipsilateral y alteración de la configuración toracoabdominal.

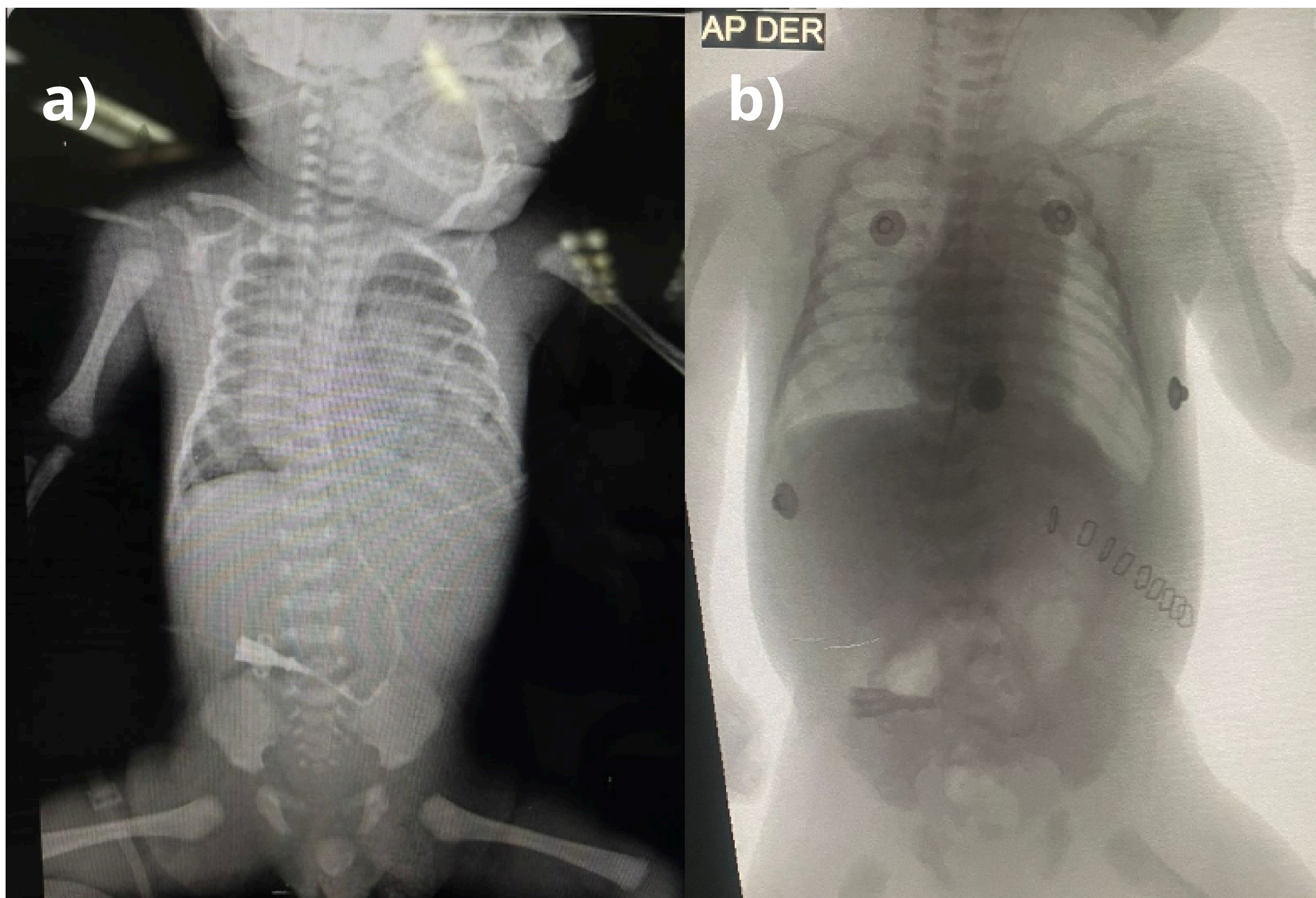


Figura 1.
a) RX preoperatoria compatible con Hernia de Bochdalek
b) RX de control postoperatorio evidenció mejoría de la anatomía toracoabdominal posterior a la corrección quirúrgica, compatible con evolución radiológica favorable.

MANEJO

Se realizó herniorrafia diafragmática, procedimiento quirúrgico mediante el cual se redujo el contenido herniado hacia la cavidad abdominal y se reparó el defecto diafragmático. La corrección permitió restablecer la separación anatómica entre cavidad torácica y abdominal, favoreciendo la expansión pulmonar posterior y la mejoría radiológica del paciente.

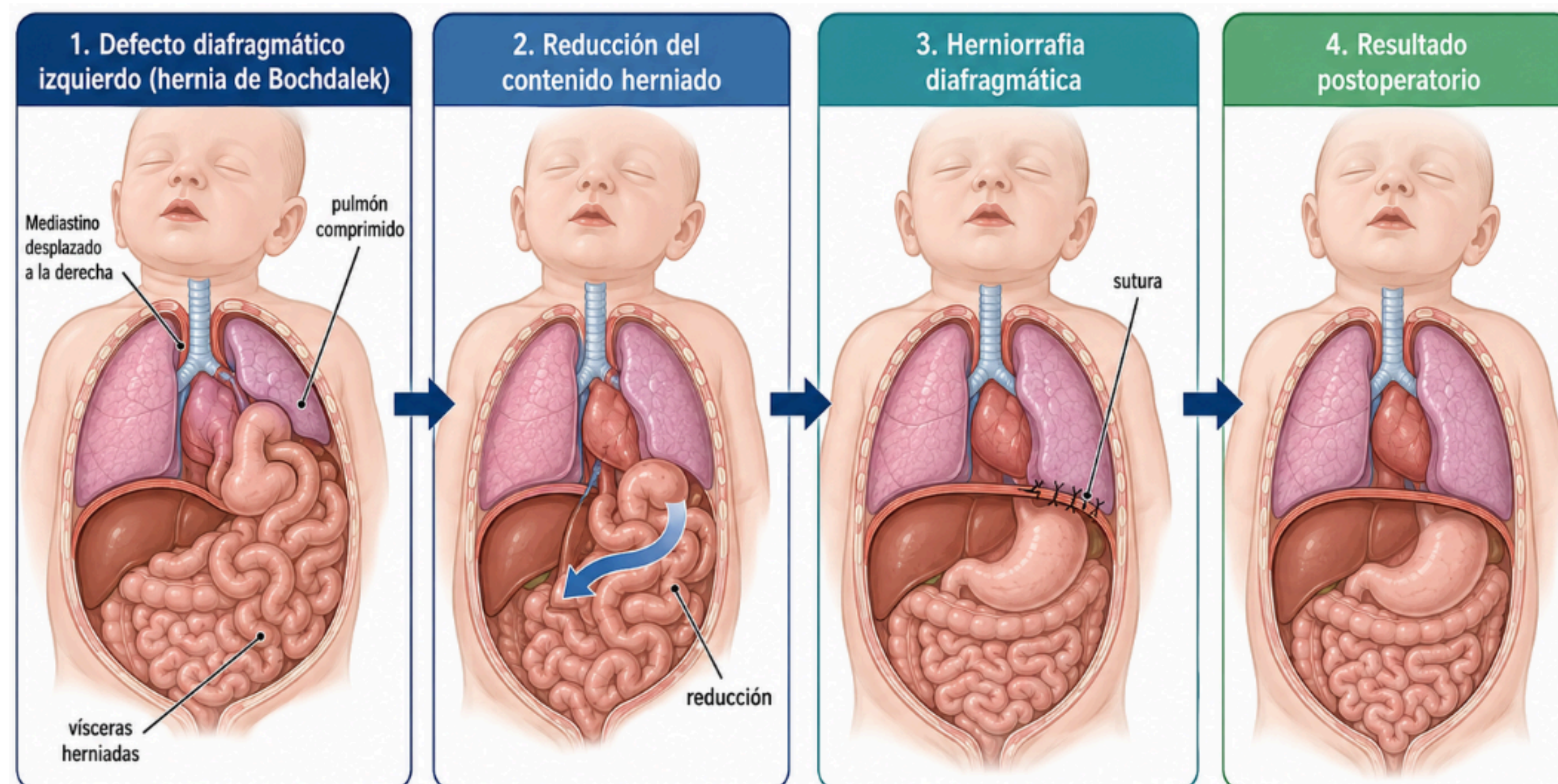


Figura 2. Esquema de técnica quirúrgica de herniorrafia diafragmática en hernia de Bochdalek izquierda.

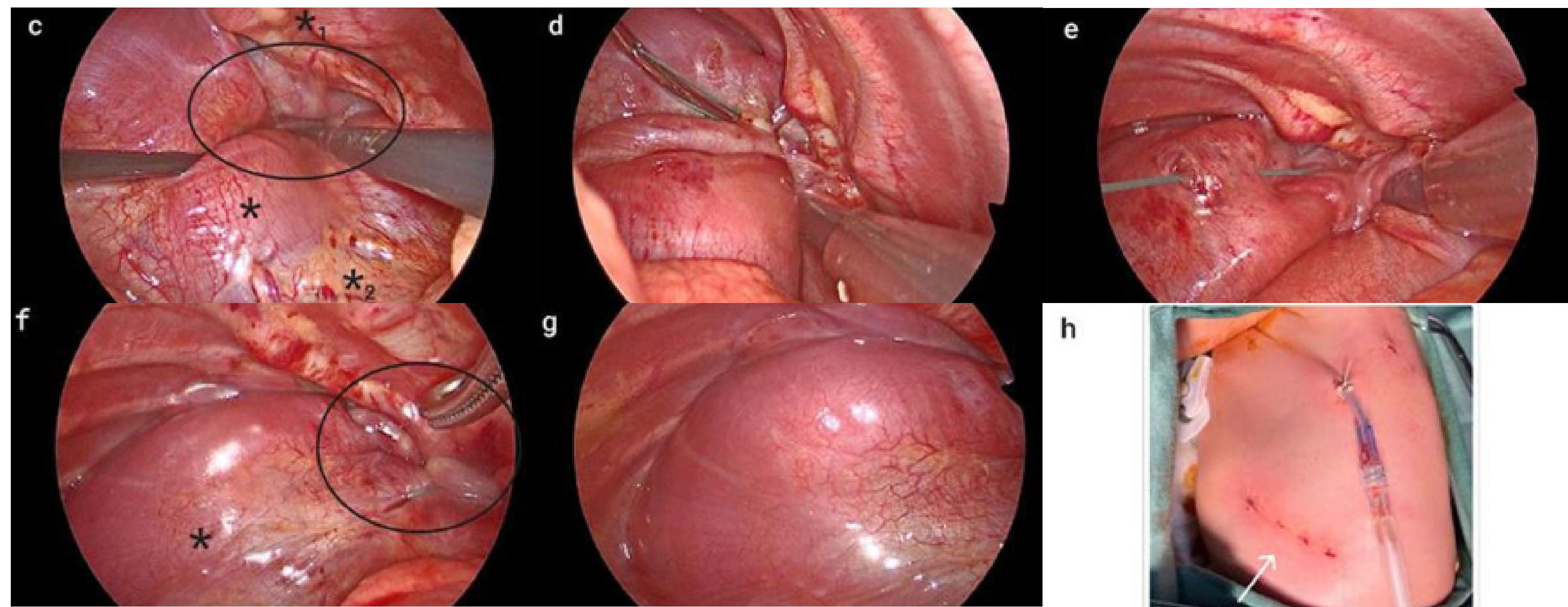


Figura 3.
c) Reducción del contenido herniario hacia el abdomen
d) y e) Herniorrafia con puntos percutáneos con aguja de Reverdin.
f) Orificio herniario cerrado; g) Resultado final, músculo diafragmático izquierdo con buena tensión; h) Incisiones en piel.

DISCUSIÓN

La hernia diafragmática congénita tipo Bochdalek representa una urgencia neonatal que requiere alto índice de sospecha. El defecto diafragmático permite el ascenso de vísceras abdominales hacia la cavidad torácica, lo que ocasiona compresión del pulmón ipsilateral y puede alterar la función respiratoria del recién nacido.

La radiografía toracoabdominal simple continúa siendo una herramienta accesible y útil para el diagnóstico inicial, ya que permite identificar la presencia de contenido abdominal en el tórax y orientar la conducta terapéutica.

El tratamiento de estos pacientes requiere un enfoque multidisciplinario, en el que participan neonatología, cirugía pediátrica, anestesiología y cuidados intensivos. En este caso, la estabilización inicial en UCIN y la posterior herniorrafia diafragmática permitieron una evolución clínica y radiológica favorable.

CONCLUSIONES

La hernia diafragmática izquierda tipo Bochdalek es una patología neonatal potencialmente grave. La radiografía toracoabdominal permite orientar el diagnóstico inicial y valorar la evolución posterior. En este caso, la herniorrafia diafragmática permitió la corrección del defecto con evolución clínica y radiológica favorable.

REFERENCIAS

Gue, R. S., Winkler, L., & Kankotia, R. (2024). Bochdalek hernia. In StatPearls. StatPearls Publishing.
Köse, E. E., & Yaçınkaya, İ. (2024). Congenital diaphragmatic hernia. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 32(Suppl. 1), S89–S97. <https://doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25705>
Puligandla, P., Skarsgard, E., Baird, R., Guadagno, E., Dimmer, A., Ganescu, O., Abbasi, N., Altit, G., Brindle, M., Fernandes, S., Dakshinamurti, S., Flageole, H., Hebert, A., Keijzer, R., Offringa, M., Patel, D., Ryan, G., Traynor, M., Zani, A., & Chiu, P. (2024). Diagnosis and management of congenital diaphragmatic hernia: A 2023 update from the Canadian Congenital Diaphragmatic Hernia Collaborative. Archives of Disease in Childhood: Fetal and Neonatal Edition, 109(3), 239–252.